

"永信"克炎膠囊

INDOMEN CAPSULES "Y.S."

內衛藥製字 第 008167 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-07-02

心血管栓塞事件：

1. NSAIDs藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品的時間越長，風險越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每膠囊中含：Indomethacin.....25mg

1.2 賦形劑

Lactose、Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Capsule #2 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Iron Oxide Yellow、Titanium Dioxide)。

1.3 劑型

膠囊劑。

1.4 藥品外觀

淺藍綠色蓋，淺黃褐色身之#2硬膠囊，蓋與身皆印有 YSP
IDC 黑色字樣，內裝白色粉末。

2 適應症

關節炎、癱瘓質斯、變形性關節症等炎症之消炎、鎮痛、解熱以及其他疾患之消炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人一次1粒，一日1~3次於飯後或進食中服用，普通之用法為於初期時一日1~2次，一次1粒，以後依實際需要可於一週間增加至一日3粒，此外如一日服用2次時可於早晚各服一次，兒童忌用。

4 禁忌

(依文獻記載)

4.1 對本藥過敏之患者。

4.2 患有Aspirin氣喘或對其他非類固醇消炎劑過敏之患者。

4.3 消化性潰瘍患者。

4.4 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。

5 警語及注意事項

(依文獻記載)

5.1 警語/注意事項

5.1.1 心血管栓塞事件

依據多項COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs之臨床試驗研究，發現使用該類藥品達三年，會增加嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。惟依目前現有研究數據，無法證實各種NSAIDs藥品是否具有相似之心血管栓塞事件風險。且無論病人有無心血管疾病或相關危險因子，發生嚴重心血管栓塞事件之相對風險，具有相似程度的增加。但是，有心血管疾病或具相關危險因子者，因本身出現心臟病發作或中風的風險即較高，故使用該類藥品後發生嚴重心血管栓塞事件之絕對風險更高。另一些觀察性研究發現，剛開始使用該類藥品的幾週內，即可能出現嚴重心血管栓塞事件，而且隨著使用劑量增加，其心血管栓塞事件之風險亦隨之增加。

為減少該類藥品之心血管不良事件潛在風險，建議儘可能使用最短治療時間及最小有效劑量。且在用藥期間，醫療人員及病人應注意心血管不良事件之發生，即使在先前未曾出現心血管相關不良症狀。病人需要被告知嚴重心血管不良事件之症狀以及發生時之處理方式。

5.1.2 冠狀動脈繞道手術(CABG)後

兩項大型臨床試驗研究顯示，於冠狀動脈繞道手術後10~14天內使用COX-2選擇性抑制劑藥品，其發生心肌梗塞及中風的情形增加。因此，進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。

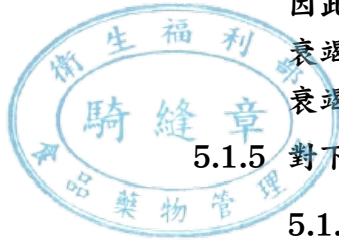
5.1.3 最近發生心肌梗塞的病人

觀察性研究顯示，在心心肌梗塞後使用NSAIDs藥品，在用藥第一週時，出現再梗塞、心血管相關死亡及整體死亡率等情形皆增加。研究亦顯示，心肌梗塞後使用NSAIDs者，其第一年死亡率為20/100人／年，而未使用NSAIDs者之死亡率則為12/100人／年。雖然使用NSAIDs者第一年後之死亡率逐年下降，但其後4年內之死亡率仍相對較高。

因此，應避免使用本藥品於最近曾發生心肌梗塞的病人，除非經評估使用藥品之效益大於再發生心血管栓塞事件之風險。若本藥品使用於近期發生心肌梗塞的病人，應嚴密監視是否出現心肌缺血之症狀。

5.1.4 心臟衰竭與水腫

隨機分派研究結果顯示，使用COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs藥品治療的病人發生心臟衰竭住院的比例為安慰劑組的兩倍。且在觀察性研究亦發現，有心臟衰竭的病人使用該類藥品，其心肌梗塞、因為心臟衰竭住院及死亡等情形皆增加。有些使用NSAIDs藥品的病人被觀察到有水分滯留及水腫等情形。因此使用本藥品可能會使一些藥品之心血管作用變得不明顯，例如diuretics、ACE inhibitors或angiotensin receptor blockers (ARBs)。



因此，應避免使用本藥品於嚴重心臟衰竭的病人，除非經評估使用之效益大於心臟衰竭惡化之風險。若本藥品使用於嚴重心臟衰竭的病人，應嚴密監視是否出現心臟衰竭惡化之症狀。

5.1.5 對下列患者須慎重投與

5.1.5.1. 嚴重之腎功能損害者。

5.1.5.2. 高血壓及心臟功能不全者。

5.1.5.3. 凝血功能異常者。

5.1.6 懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕20週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全(fetal renal dysfunction)、羊水過少(oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷(renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期20至30週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過48小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。

5.5 其他注意事項

5.5.1 使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法而非原因療法。

5.5.2 本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察慎重投與。

5.5.3 本藥可能隱蔽細菌感染之病徵，在臨床報告為充分明瞭之前禁止兒童使用。

5.5.4 本藥可能引起白血球減少症、血小板減少症、顆粒性白血球缺乏病、胃腸出血及尿血症，如患者用藥後發生視覺問題應加注意。

5.5.5 使用於治療慢性疾病時，可能會出現暫時性之SGPT SGOT值之上昇現象，此時應立即停藥。

6 特殊族群注意事項

(依文獻記載)

6.1 懷孕

對孕婦之安全性尚未確立。對於孕婦及可能懷孕之婦女宜權衡利弊後再行投與。

抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和／或胚胎／胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前／後胚胎損失率及胚胎／胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形(包括心血管畸形)之發生率增加。

6.2 哺乳

對授乳婦之安全性尚未確立。對於授乳婦宜權衡利弊後再行投與。

7 交互作用

(依文獻記載)

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

(依文獻記載)

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 胃腸系統：噁心、嘔吐、消化不良（包括胸口灼熱感及上胃部疼痛）、下痢、腹部緊迫或疼痛、便秘，罕有胃腸出血之病例發生。

8.1.2 神經系統：頭痛、眩暈、嗜眠、抑鬱、疲倦（包括不適感及精神慵懶）偶有發生。

8.1.3 其他：服用後偶有耳鳴之現象。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

(依文獻記載)

目前尚無資訊。

10 藥理特性

(依文獻記載)

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

本藥之主成分Indomethacin是非類固醇性抗炎症劑，此類藥物在基礎實驗中與以往同類之種種藥劑的比較，證明具有較優秀之抗發炎、鎮痛及解熱作用。在臨床上亦被確認對炎症有卓越的抑制作用，不但對慢性關節痠麻質斯及變形性關節症有效，同時對近似疾患及各科之疼痛及腫脹等各種炎症性疾患亦有治療之價值，又併用本藥對副腎質Steroid劑之節減及脫離作用亦被確認為有效。

10.2.1 有抗炎、鎮痛、解熱作用且較優於以往同類藥劑。

10.2.2 具有速效性的效果

Indomethacin為微細粉末膠囊劑於口服後1~2小時即可達到血中最高濃度，而能夠迅速的緩和疼痛、壓痛、腫脹等症狀。

10.2.3 能節減副腎皮質Steroid劑

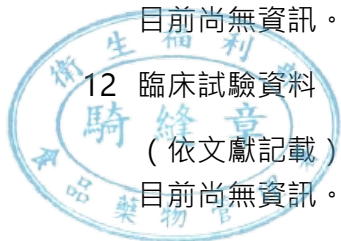
Indomethacin具有抗炎作用，而無荷爾蒙樣之作用，在其抗炎症作用並不是介入副腎皮質荷爾蒙之結果，因此在從前之藥劑不能充分使副腎皮質Steroid節減，而現在由於併用本藥，可於得到對有些症例，甚至「自Steroid劑之脫離」亦可通用，而且可安心使用副作用較少的本藥來代替從前使用之副腎皮質Steroid劑。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

(依文獻記載)



12 臨床試驗資料
(依文獻記載)
目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2~1000粒玻璃瓶、塑膠瓶、罐、鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝標示。

13.3 儲存條件

於25°C以下儲存。

13.4 儲存注意事項

本藥應置於小兒伸手不及處。

請在有效期限內使用。

製造廠

永信藥品工業股份有限公司台中幼
獅廠

台中市大甲區日南里工九路27號

藥商

永信藥品工業股份有限公司

台中市大甲區頂店里中山路一段1191號